EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73828
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-09 10:12:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERTA INES PALMA CISTERNA			RUN	: 4.630.427-6
F.Nac	: 17-05-2022	Edad	: 1 AÑO, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-25	Fecha Egreso	: 2023-11-09 10:12:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I60-I69-ENFERMEDADES CEREBROVASCULAR

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV frontoinsular derecho cardioembólico
-TEP lobar inferior y medio derechos. Signos HTP
-ITU por Aerococcus urinae, tto completado meropenen 7 dias
-FA en TACO
-EPOC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 84 años de edad con antecedente de EPOC, FA en TACO, acude a SU HSC traída por SAMU desde su domicilio por presentar cuadro clínico caracterizado por dificultar para articular palabras y déficit motor en HI con desviación de rasgos faciales (según referencia del SAMU pte logra decir que amaneció con dichos síntomas) Al ingreso de urgencia paciente con disartria, hemiparesia faciobraquiocrural izquierda, sin compromiso de conciencia PA: 160/110mmhg FC: 56x´Sato2 93% se realiza TAC cerebro con evidencia de signo de la cuerda a derecha como signo precoz de isquemia, con cambios involutivos centrales y periféricos , calcificaciones fisiológicas, isquemia crónica en hemisferio crebeloso izq y occipital izq AngioTAC: estenosis distal de M1, enfermedad ateroesclerotica Arteria carotida interna der e izq con estenosis cercana 30% en esta ultima, con trombo oclusivo en tercio prox de subclavia izquierda que compromete emergencia de vertebral Tratamiento crónico: Telmisartan 80/HCT 12,5mgrs, amlodipina 10mgrs, Atenolol 50mgrs vo , Acenocumarol segun esquema de TACO, Digoxina 1/2 Se recibe en sala con cifras de PA elevadas 182/97mmhg PAM: 114mmhg FC 72x´con Ritmo de FA en monitor Sato2 > 92% Al ex. físico: palidez cutáneo mucosa moderada, cuello con pulsos carotideos palpables y simétricos NAS. cardiopulmonar: mp+ con crepitantes bilaterales, Rs Cs arritmicos NAS Abdomen: impresiona globo vesical, doloroso a la palpación en region suprapúbica Neurológico: Mental: somnolienta, orientada en persona, disartria moderada a severa PC: pupilas der puntiforme, izq discorica, CV no evaluables, MOC conservados, PFC izq, no protruye lengua, sensibilidad facial no evaluable Motor: hemiparesia izquierda braquial M0, Crural M2, arreflexia patelar y aquiliana, cutáneo plantar extensor izquierdo, flexor derecho Sensibilidad: algesica impresiona conservada Cerebelo: no evaluable Signos meníngeos negativos
En su evolución presenta disnea con aumento de requerimientos de o2 se realiza AngioTAc de torax con evidencia de TEP bilateral , asi mismo presento elevacion de parametros inflamatorios con OC patologica UROC + para A. urinae por l cual completa esquema antibiotico con Meropenem durante 7 dias
Hoy en condiciones clinicas estables mas reactiva y cooperadora, mantiene regimen por SNG y diuresis por CUP

Sin deterioro neurologico , se decide alta medica con HODOM para continuar rehabilitacion kinesica y fonoaudiologica.

PLAN DE MANEJO:

Continuar rehabilitacion kinesica y fonoaudiologica con HODOM
Se egresa con SV ya que a su retiro presento globo en varias ocasiones y amerito sondaje intermitente
Control en Poli de neurologia en 15 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
2. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
3. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
4. CARVEDILOL COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
5. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 2 PUFF CADA 12 HORAS
8. BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025% NBZ CADA 6 HORAS + SOS
9. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. APIXABAN COMPRIMIDO 5 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 0,50 * mg/dl 0,52 - 1,04
Calcio : 8,6 mg/dL 8,4 - 10,2
Clearence Calculado(MDRD) : 117,54 ml/min/1,73 | > 60
Proteina C Reactiva : 30,1 * mg/L
Sodio (Na) : 134,00 * mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 4,50 mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro (Cl) : 99,00 mmol/L 96,00 - 106,00

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO